

长春瑞滨联合小剂量甲氨蝶呤治疗不可切除硬纤维瘤的临床研究

李舒, 方志伟, 樊征夫, 白楚杰, 刘佳勇, 陈静, 薛瑞峰

李舒 博士、住院医师

北京肿瘤医院 骨与软组织肿瘤科

摘要:【目的】分析硬纤维瘤的临床特点, 探讨硬纤维瘤保守治疗的效果。【方法】对2008年1月-2011年1月间我科治疗的28例不可手术切除的硬纤维瘤患者的临床病例资料进行回顾性研究。【结果】28例病人中, 有24例完整随访。所有病人都接受长春瑞滨联合小剂量甲氨蝶呤方案化疗, 化疗周期由2个月至12个月不等, 中位化疗周期为8.5月。随访时间从2个月到38个月不等, 中位随访时间12个月。化疗病人中1例CR, 9例PR, 14例SD。完成12个月完整化疗的患者中60%达到PR, 40%达到SD。患者对化疗副反应均能耐受。【结论】对于复发及不可切除的硬纤维瘤, 若患者因年龄小而不适于放疗的话, 长春瑞滨联合小剂量甲氨蝶呤方案化疗是一种合适的选择。

关键词: 硬纤维瘤、侵袭性纤维瘤、保守治疗

硬纤维瘤(desmoid tumor), 亦称侵袭性纤维瘤病(aggressive fibromatosis)、韧带样纤维瘤病(desmoid type fibromatosis), 由MacFarlane于1832年首先描述, 是一种罕见的成纤维细胞来源的肿瘤。硬纤维瘤占所有肿瘤的0.03%, 年发病率为百万分之2-4人。该病可发生于全身很多部位, 好发部位依次为肩胛带、腹壁、下肢、骨盆带、躯干、上肢、头颈、胸壁、乳房。硬纤维瘤好发于女性及成年人。硬纤维瘤发病的危险因素主要有家族性腺瘤性息肉病(FAP)病史、Gardner综合征病史、外伤史、女性。硬纤维瘤的临床过程多变, 可稳定、侵袭性生长或自然消退。硬纤维瘤不会向淋巴结及远处转移, 局部复发主要是因为其浸润性生长的特性而不是由于卫星灶及跳跃转移。该病罕见恶变, 国内曾有一例恶变为纤维肉瘤的报道, 该例恶变考虑可能与手术刺激、放射治疗有关。硬纤维瘤的复发多发生在术后前2年内。本文对我科自2008年1月至2011年1月间收治的28例不可手术硬纤维瘤患者的临床特点、治疗及随访情况总结如下。

1、材料与方法

1.1、临床资料

我科自2008年1月至2011年1月共收治不可手术的硬纤维瘤患者28例, 所有病例均经病理确诊。在此28例病人中, 男性15例, 女性13例。发病年龄从2岁到44岁, 中位发病年龄16岁。其中68%的病人发病时小于20岁。所有病人中仅有2例为初治, 其余病人均为术后复发后来我科治疗。有的患者经过4次手术仍然复发。所有复发病人在第一次手术前诊断均未考虑硬纤维瘤。28例病人中, 7例(25%)病人无不适症状, 仅表现为局部肿块; 12例(42.9%)病人表现为肿瘤所在肢体的活动障碍; 13例(46.4%)病人伴有疼痛, 但程度均较轻。2例(7.1%)盆腔硬纤维瘤患者的症状表现为大小便异常。2例病人的病灶处(一位于肩胛处, 一位于肘部)有先前明确的外伤史。在所有病人中未发现明确的雌激素药物服用史及FAP病史。发病部位为下肢10例(35.7%), 臀部及髋部7例(25%), 上肢4例(14.3%), 躯干3例(10.7%), 肩胛部2例(7.1%), 盆腔2例(7.1%)。

1.2、治疗方法

所有病例经MRI、CT或B超评估均无法在保留肢体功能及完整外观的情况下达到根治切除。所有患者接受统一方案的化疗, 化疗方案具体为(长春瑞滨 $6-10\text{mg}/\text{m}^2/\text{Qw}$ ivgtt+小剂量甲氨蝶呤 $30\text{mg}/\text{m}^2/\text{Qw}$ 分5天口服), 化疗持续时间2个月至12个月不等, 中位化疗周期为8.5月。

1.3 随访

通过电话及门诊随访。通过MRI、CT、B超评估化疗效果。接受化疗病人随访时间从2个月到38个月, 中位随访时间12个月。28例病人中24例接受完整随访。

2、结果

接受化疗的24例病人中, 1例(4.2%)完全缓解(CR), 9例(37.5%)部分缓解(PR), 14例(58.3%)疾病稳定(SD), PR病人中化疗起效时间最短为1月, 最长为12月。完成12个月完整化疗的患者中60%达到PR, 40%达到SD。接受化疗治疗的病人中有20例出现化疗副反应, 主要包括消化道反应如恶心、呕吐(20.8%), 肝功能损伤(54.2%), 骨髓抑制(37.5%), 口腔溃疡(37.5%)等, 分别给予止吐、保肝、升白等对症支持治疗后, 患者化疗副反应均能缓解。肝功损伤及骨髓抑制主要由甲氨蝶呤导致。故甲氨蝶呤起始剂量由患者体表面积决定, 但之后剂量需根据化疗副反应程度调整。口腔溃疡可予亚叶酸

钙剂漱对症治疗。

3、讨论

目前普遍认为手术应为硬纤维瘤的一线治疗,对于硬纤维瘤患者,手术如可以保留肢体的良好功能和外观,并达到阴性切缘,应只进行手术切除,术后予以随访观察。有学者发现切缘阴性者局部控制率较阳性者高。甚至有文献报道,认为唯一可减少复发的因素是切缘阴性。所以,在能保留功能及良好外观的前提下,手术应尽量达到阴性切缘,这对减少术后复发非常重要;但是也不能为了达到阴性切缘而牺牲肢体的功能与外观,因为切缘阳性者不仅术后还可接受放疗,而且复发后还有二次手术机会。另外,硬纤维瘤不会危及生命,因此和一般恶性肿瘤不同,不需要牺牲功能的根治性切除。本组患者中,在外院有1例接受大腿截肢术、1例接受足趾截趾术,术后仍发生截肢和截趾近心端的肢体肿瘤复发,来我们科经过化疗后病情得到控制。所以,对于截肢应持慎重态度,因为该病罕见恶变,不会转移,若肢体还有功能,应尽量选择保肢,并给予辅助治疗。有学者认为截肢的指证应是肿瘤累及神经血管和主要的骨,以及肢体无功能或疼痛。另有A. Gronchi等人报道了203例接受手术的硬纤维瘤患者,结果发现初治者术后的无病生存率比复发者术后的无病生存率高(十年生存率:初治者为76%,复发者为59%)。这就要求医生对初治的硬纤维瘤患者做到准确诊断,正确治疗。

放疗应为二线治疗,镜下有残余病灶的患者应该根据肿瘤部位及范围考虑接受辅助放疗。肿瘤不可切除或切除后会导致严重功能障碍的病人,应该单纯接受放疗。但硬纤维瘤病人中很多是年轻人或者儿童,本组病例中68%的病人发病时小于20岁,最小的患者年龄仅2岁,放疗对此类人群可能会造成一定的迟发的并发症,主要包括:肢体挛缩、生长障碍、继发恶变。

药物治疗被认为是继手术和放疗之后的三线治疗。肿瘤不可手术和/或放疗的病人应该接受药物治疗。本组病人的治疗选择的均为长春瑞滨+小剂量甲氨喋呤化疗。Azzarelli等曾报道了对30例不能手术的硬纤维瘤患者,使用小剂量长春碱和甲氨喋呤化疗,达到了40%的反应率,十年的生存率(包括无病和进展)达到67%。进一步有学者发现使用长春碱化疗,有约10%的病人发生外周神经病变的副反应。而长春瑞滨神经毒性比长春碱小,但疗效和长春碱相当。因此提出使用长春瑞滨联合甲氨喋呤治疗硬纤维瘤。该方案最大的优点是急性及长期的化疗毒性小,且方便门诊进行,从而提高了患者的依从性。关于化疗周期,目前尚无共识,但有学者建议即使没有影像学上化疗有反应的证据,化疗也应持续至少一年,除非疾病进展和出现严重的化疗毒性。

根据我们的经验,对于复发及不可切除的硬纤维瘤,若患者因年龄小而不适于放疗的话,长春瑞滨联合小剂量甲氨喋呤方案化疗是一种合适的选择。在中国很多医院,对于复发及巨大的硬纤维瘤患者,仍在进行截肢手术,但是截肢不仅会造成肢体功能的丧失,而且不能阻止残端复发。因此,我们希望我们的研究能为此类患者提供更好的选择。

软组织恶性纤维组织细胞瘤术前化疗的临床观察

张平 李鼎峰 刘蜀彬 王磊 范海涛 崔秋 周举 刘 斌 姜维浩

(军事医学科学院附属医院解放军 307 医院骨科, 北京, 100071)

摘要 目的: 观察软组织恶性纤维组织细胞瘤术前灌注化疗的疗效。方法: 44 例软组织恶性纤维组织细胞瘤。患者术前采用皮下埋植式动脉介入化疗系统, 用阿霉素和顺铂为主, 联合咖啡因或去甲斑蝥素治疗。结果: 病变影像改变 RR18 例, 病理中重度以上化疗反应 15 例, 平均随访 39 个月, 术后肿瘤局部复发 2 例, 肺转移 1 例, 3 例死亡。结论: 软组织恶性纤维组织细胞瘤的治疗可以选择动脉灌注化疗, 以化疗后手术切除的肿瘤病理改变作为重要的预后评价标准。

关键词 埋植式动脉介入化疗, 软组织恶性纤维组织细胞瘤, 咖啡因, 去甲斑蝥素

The Clinical analysis of Observations on Preoperative Chemotherapy of Recurrent Soft Tissue Liposarcoma

Abstract

Objective: To investigate the effect of preoperative induction chemotherapy on treatment of recurrent liposarcoma. **Methods:** 21 patients with recurrent liposarcoma received the treatment of preoperative intra-arterial chemotherapy and surgical resection. Intra-arterial chemotherapy was given by subcutaneous implantable drug delivery system with infusion of cisplatin and doxorubicin followed by caffeine. After treatment, patients were followed up for 39 months. **Results:** The liposarcoma changes in CT imaging were observed in 18 cases and there were 15 cases with medium or severe pathological changes caused by chemotherapy. At the end of the postoperative follow-up of 39 months, liposarcoma reoccurred locally in 2 cases; pulmonary metastasis occurred in 1 case and death in 3 cases. **Conclusion:** Preoperative intra-arterial chemotherapy is effective for highly malignant tumors such as recurrent